EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 93008
SERVICIO : MEDICINA HSC
FECHA : 2024-09-17 10:14:00

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: NELIDA DEL ROSARIO ORTIZ FIGUEROA			RUN	: 6.130.532-7
F.Nac	: 09-05-1944	Edad	: 80 AÑOS, 4 MESES	Género	: Femenino
Dirección	:			Comuna	: SAN NICOLAS
Previsión	: SIN INFORMACION	Teléfono	: 0		
Fecha Ingreso	: 2024-09-14	Fecha Egreso	: 2024-09-17 10:14:00	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. J84.1-OTRAS ENFERMEDADES PULMONARES INTERSTICIALES CON FIBROSIS

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

) Fibrosis pulmonar sobreinfectada en tratamiento
2) IC
3) HTA
4) DM2

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. J84.9-ENFERMEDAD PULMONAR INTERSTICIAL, NO ESPECIFICADAA (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Paciente con antec descritos, consulta en primera isntancia en HCHM por cuadro de diasnea de una sem de evolucion, progresiva, CEG; cefalea, rinorrea, tos productiva
Se solicita placa de torax donde se describe opacidad basal izquierda, compatible con fibrosis pulmonar sobreinfectada
Vigil; CLOTE; mucosas rosadas, hidratadas, llene capilar < 2 segs, con uso de musculatura accesoria supraclavicular
Cardiaco RR2T NAS
Pulmonar MP (+), estertores y sibilancias difusas
Extremidades +/+++ bilateral
Se decide ingreso para KNT rehabilitadora + terapia ATB, durante su estadia paciente HDN estable, afebeil, sin requeimiento de O2 suplentario, saturando 90-93% en estas ultimas 24 hrs ambiental, sin disnea al interrogatorio dirigido, con buena tolerancia a aliemtnacioN VO, sin episodios de nauseas y/o vomitos, diuresis (+), deposiciones (+)

Ex de lab -> proca 0,02; PCR < 5, proBNP 151, TSH 1,58; T4L 1,06; GSA pH 7,46, pO2 69,1; HCO3 30,8

Ex fisico -> Vigil, CLOTE; mucosas rosadas, hidratadas, llene capilar < 2 segs
Cardiaco RR2T NAS
Pulmonar MP (+) SRA
ABdomen BDI, RHA (+), sin megalias, sin signos de irritacion peritoneal
Extremidades sin edema, sin signos de TVP

PLAN DE MANEJO:

1) HDN: Estable, sin conflicto
2) VEntilatorio: Estable, sin conflicto, sin requerimiento de O2 suplementario
3) Infeccioso/Respiratorio: Parametros inflamatorios a bajos, se completara 7 dias de terapia ATB sumado a KNT respiratoria rehabilitadora via HODOm

INDICACIONES AL ALTA

1. Reposo semisentada 30°
2. Regimen diabetico hiposodico a tolerancia
3. Ceftriaxona 2 gr al dia EV por 4 dias
4. Azitromicina 500 mg al dia VO por 2 dias
5. Omeprazol 20 mg al dia VO por 4 dias
6. Paracetamol 500 mg, 2 comp c/8hrs VO SOS por 4 dias
7. Bromuro de ipratropio 4 puff c/6hrs por AC
8. Brexotide 2 puff c/12 hrs por AC
9. Insulina NPH 24 UI AM 20 UI PM SC
10. KNT respiratoria una vez al dia
11. CSV c/8 hrs
12. Examenes de control 20/09
13. HGT precomidas + IC segun esquema

DANIEL EDUARDO ACEVEDO PEREIRA
MEDICO TRATANTE
18431829-6

JEFE SERVICIO